

Περίπτωση 27η

Άνδρας 49 ετών, βαρύς καπνιστής, προσέρχεται στο τμήμα επειγόντων περιστατικών λόγω επανειλημμένων επεισοδίων εμέτων το τελευταίο 8ωρο.

- (FiO₂ 21%)
- PO₂ = 55 mmHg
- PCO₂ = 58 mmHg
- pH = 7.39
- [HCO₃⁻] = 34 mEq/L

- [Na⁺] = 133 mEq/L
- [K⁺] = 3.8 mEq/L
- [Cl⁻] = 100 mEq/L
- [Γλυκόζης] = 110 mg/dl
- [Ουρίας] = 82 mg/dl
- [Κρεατινίνης] = 1.4 mg/dl

Ποια είναι η διαταραχή της οξεοβασικής ισορροπίας;

- α. Χρόνια αναπνευστική οξέωση
- β. Οξεία αναπνευστική οξέωση
- γ. Αναπνευστική οξέωση + μεταβολική οξέωση
- δ. Αναπνευστική οξέωση + μεταβολική αλκάλωση

- pH = 7.39 (< 7.40)
- PCO₂ = 58 mmHg (> 40 mmHg)
- **Αναπνευστική οξέωση (κύρια διαταραχή)**

Η αναπνευστική οξέωση είναι οξεία ή χρόνια; Αμιγής ή συνυπάρχει μεταβολική διαταραχή;

- $[\text{HCO}_3^-] = 34 \text{ mEq/L}$, $\uparrow$ κατά 10 mEq/L
- $\text{PCO}_2 = 58 \text{ mmHg}$, $\uparrow$ κατά 18 mmHg
- Οξεία ΑΟ (;) $\Rightarrow \uparrow [\text{HCO}_3^-]$ κατά 1 mEq/L για κάθε $10 \text{ mmHg} \uparrow$ της PCO_2 , δηλαδή $[\text{HCO}_3^-] = 24 + 1.8 = 25.8 \text{ mEq/L}$
- Χρόνια ΑΟ (;) $\Rightarrow \uparrow [\text{HCO}_3^-]$ κατά 3.5 mEq/L για κάθε $10 \text{ mmHg} \uparrow$ της PCO_2 , δηλαδή $[\text{HCO}_3^-] = 24 + 6.3 = 30.3 \text{ mEq/L}$
- $\uparrow [\text{HCO}_3^-] > 3.5 \text{ mEq/L}$ για κάθε $10 \text{ mmHg} \uparrow$ της PCO_2
- **Αναπνευστική οξέωση + Μεταβολική αλκάλωση**
(πιθανή ΧΑΠ) + (έμετοι)

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗΣ ΟΞΕΩΣΗΣ

pH < 7,4 και PCO₂ > 40 mmHg

Αναπνευστική οξέωση

Πόση είναι η [HCO₃⁻]

↑ [HCO₃⁻] είναι < 1 mEq/L
για κάθε 10 mmHg
↑ της PCO₂

Συνυπάρχει
μεταβολική οξέωση

↑ [HCO₃⁻] = 1 mEq/L
για κάθε 10 mmHg
↑ της PCO₂

Οξεία αναπνευστική
οξέωση

↑ [HCO₃⁻] = 1-3,5 mEq/L
για κάθε 10 mmHg
↑ της PCO₂

• Περίοδος
μετάβασης
• Μικτή διαταραχή

↑ [HCO₃⁻] = 3,5 mEq/L
για κάθε 10 mmHg
↑ της PCO₂

Χρόνια
αναπνευστική οξέωση

↑ [HCO₃⁻] είναι > 3,5 mEq/L
για κάθε 10 mmHg
↑ της PCO₂

Συνυπάρχει
μεταβολική αλκάλωση

(A-a) DO₂

- (A-a) DO₂ = [150 – 1.25 X (PCO₂)] - PaO₂ = [150 – (1.25 X 58)] – 55 = 150 – 72.5 – 55 = 22.5 mmHg
- ↑ (A-a) DO₂ = πνευμονική νόσος (πιθανή ΧΑΠ)

- Συμπερασματικά, ο ασθενής εμφανίζει αναπνευστική οξέωση και μεταβολική αλκάλωση λόγω πιθανής χρόνιας αποφρακτικής πνευμονοπάθειας και επανειλημμένων επεισοδίων εμέτων

Ποια είναι η διαταραχή της οξεοβασικής ισορροπίας;

- α. Χρόνια αναπνευστική οξέωση
- β. Οξεία αναπνευστική οξέωση
- γ. Αναπνευστική οξέωση + μεταβολική οξέωση
- δ. Αναπνευστική οξέωση + μεταβολική αλκάλωση